ONEMA-POP-054 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Triagem de Obstrução de Vias Aéreas e Episódios Compatíveis com

Laringoespasmo

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de triagem de obstrução de vias aéreas e episódios compatíveis com laringoespasmo, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui

prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Telefone/vídeo, checklist de obstrução de vias aéreas, acionamento SAMU. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Determinar capacidade de falar/tossir/respirar, estridor, cianose, nível de consciência e contexto do episódio. Confirmar identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar localização e telefone para resgate logo no início.

02. Perguntar se a pessoa consegue falar, tossir efetivamente e respirar; diferenciar obstrução grave de tosse eficaz.

03. Na obstrução grave, orientar acompanhante a acionar SAMU 192 imediatamente e seguir instruções do regulador.

04. Não recomendar exploração digital às cegas nem oferecer líquidos/alimentos.

05. Se perda de consciência, orientar início de RCP pelo socorrista conforme treinamento e orientação do SAMU.

06. Em suspeita de laringoespasmo com estridor ou incapacidade respiratória, tratar como emergência, sem diagnóstico

remoto definitivo.

07. Manter chamada aberta, verificar evolução respiratória e chegada do resgate.

08. Registrar horários, sinais relatados, orientações e desfecho.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Apneia, cianose, incapacidade de falar, rebaixamento: emergência imediata. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar

o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Mesmo após melhora de episódio grave, orientar avaliação presencial por risco de lesão/aspiração.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

AHA 2025 CPR/ECC Guidelines; ERC Resuscitation Guidelines 2025 (verificar versão integral) | Conferir aplicação integral

ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.